

Überprüfung der Dokumente am:	durch:
Überprüfung der praktischen Umsetzung am:	durch:

1. Einrichtung:

2. Hygienemanagement

Hygienebeauftragter(Name):	IST-Stand	Bemerkungen
Qualifikation zum Hygienebeauftragten	☐ Ja ☐ Nein	
Hygieneplan vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Letzte Aktualisierung des Hygieneplanes - Datum:	jährlich aktualisiert ☐ Ja ☐ Nein	
Letzte Belehrung der MA (1x jährlich) Datum:	jährlich ☐ Ja ☐ Nein	
Hygieneplan für alle MA jederzeit zugänglich und einsehbar:	☐ Ja ☐ Nein	
Reinigungs- und Desinfektionspläne erarbeitet und gut sichtbar ausgehängt (Was, Wann, Womit, Wie, Wer, Datum und Unterschrift)	☐ Ja ☐ Nein	

3. Basishygiene als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

3.1. Allgemeine Wohn- und Sanitärhygiene (gilt für Angehörige)

Allgemeine Wohnhygiene (Feuchtbereiche, Lebensmittelkontaktflächen, Utensilien zur Nassreinigung)	☐ Ja ☐ Nein	
Einsatz von Desinfektionsmittel nur in Ausnahmesituationen, nicht routinemäßig notwendig !		
Lebensmittelhygiene - Händehygiene vor und nach Umgang mit Lebensmittel - gründliches Reinigen der Kontaktflächen - Regelmäßiges Wechsel der Spüllappen und Geschirrtücher - Kühlagerung verderblicher Lebensmittel - Regelmäßige Reinigung von Kühlschrank- und Schrankinnenflächen	☐ Ja ☐ Nein	
Persönliche Hygiene – gründliches Händewaschen mit fließendem Wasser und Seife - vor Einnahme bzw. Verabreichung von Speisen und Medikamenten - vor dem Einsetzen von Kontaktlinsen und Zahnprothesen - nach Toilettenbenutzung - nach Kontakt mit Sekreten, kontaminierten Abflüssen in Küche und Sanitätsbereich - nach Kontakt mit Haustieren und deren Pflege - nach sichtbarer Verschmutzung der Hände Verwendung von Händedesinfektionsmitteln im Hausgebrauch ist nur in besonderen Situationen, nicht routinemäßig notwendig.	☐ Ja ☐ Nein	
Beratung der Angehörigen, insbesondere bei Infektionsübertragung	☐ Ja ☐ Nein dokumentiert: ☐ Ja ☐ Nein	

3.2. Reinigung, Desinfektion und Instrumentenaufbereitung als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches (gilt nur für Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes)

Allgemeine Regeln: - gründliche und regelmäßige Reinigung der Hände und benutzten Flächen ist wesentliche Voraussetzung für einen guten Hygienestatus - Einsatz von Desinfektionsmittel erfolgt angemessen - Gezielte Desinfektion erforderlich, wo Krankheitserreger auftreten (z.B. Verunreinigungen mit Erbrochenem, Blut, Stuhl, Urin), mit geeigneten Mitteln und Einwirkzeit (Desinfektionsliste der DGHM)	☐ Ja ☐ Nein	
Auftreten meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten, mit Gesundheitsamt abgestimmt	☐ Ja ☐ Nein	

3.2.1. Händehygiene als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Händewaschen - Flüssigseife, Einmalhandtücher und Händedesinfektionsmittel sind mitzuführen Wann?: - Dienstbeginn, Pflegemaßnahmen, Verschmutzung, Toilettenbenutzung - Lebensmittelumgang, Einnahme von Speisen u. Getränke, Tierkontakt	☐ Ja ☐ Nein	
--	---	--



- bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen, Blut sind med. Einmalhandschuhe zu verwenden - Seifenstücke; textile Gemeinschaftshandtücher ist abzulehnen	☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein	
Hygienische Händedesinfektion - Entfernung sichtbarer grober Verschmutzungen mit Zellstoff/ Desinf. Einmaltuch - 3-5 ml des Präparates in die trockenen Hände einreiben, mind. 30 sek. mit Desinfektionslösung feucht halten - Verwendung von Einmalhandschuhen In der Liste der DGHM gelistet?	☐ Ja ☐ Nein Welches Mittel, Hände? Einwirkzeit eingehalten? ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ ein	<u>Pflegassessment übernehmen!</u>
Festlegung wann hyg. Händedesinfektion erforderlich: - vor invasiven Maßnahmen (Punktionen, Legen von Katheter usw.) - vor dem Anlegen von Verbänden - vor Manipulation an liegenden Katheter - vor und nach pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen - nach Kontamination der Hände/ Handschuhe mit Blut, Sekreten oder Ausscheidungen - nach dem Ablegen der Schutzhandschuhe - nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und Flächen - nach Kontakt mit Patienten, die infektiös bzw. potenziell infektiös sind	☐ Ja ☐ Nein Wird von MA umgesetzt? ☐ Ja ☐ Nein	<u>Auftretende Probleme, Pflegeassessment</u>

3.2.2. Flächen / Gegenstände als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Reinigung im Umfeld des Pflegebedürftigen, vorzugsweise Feuchtreinigung (Wasser + Haushaltsreiniger) ist ausreichend	☐ Ja ☐ Nein	
Festlegungen von Desinfektionsmaßnahmen für besondere Situationen und Anlässen (Tragen von Schutzkleidung)	☐ Ja ☐ Nein	
<u>Sind Flächendesinfektionsmittel vorhanden?</u>	☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein	Verwendete Mittel stimmen mit dem Hygieneplan überein? ☐ Ja ☐ Nein

3.2.3. Instrumentenaufbereitung / Sterilisation als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Sachkundiges Personal ist vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Einweisungsnachweise des sachkundigen Personals sind vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein	
Der Ort der Sterilisation ist festgelegt?	☐ Ja ☐ Nein	
Reihenfolge: Desinfizieren, Reinigen, Spülen, Trocknen, Pflegen, Prüfen, Sterilisieren	☐ Ja ☐ Nein	
Gebrauchtes Instrumentarium ist sicher, in festen durchstichsicheren, desinfizierbaren Transportbehältnissen zu Wiederaufbereitung zu transportieren.	☐ Ja ☐ Nein	
DGHM - gelisteten Mittel, Wirksamkeit gegen Hepatitis – B – Viren ist notwendig	☐ Ja ☐ Nein	
Welches Mittel wird verwendet:.....		
Dokumentation und Sterilgut mit Datum versehen (gilt auch für Verfallsdaten bei Einmalgebrauch)	☐ Ja ☐ Nein	

3.2.4. Wäschehygiene und Bekleidung als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Patienten: Wäschewechsel: - Bei Verschmutzung sofort, sonst Bettwäsche alle 2 Wochen, bei Bettlägerigen wöchentlich - Handtücher 2x wöchentlich - Waschlappen tgl., besser Einmalgebrauch - Unterwäsche täglich Wäschebehandlung: - Leib-, Bettwäsche, Handtücher bei min. 60°C - Mit Stuhl, Blut und Urin verunreinigte Wäsche nach Möglichkeit 10 min kochen	☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein	
--	--	--



Personal: Dienstkleidung: - min. 60°C waschbar bzw. chemo-thermisch 40°C - Wechsel in der R. alle 2 Tage, bei Verschmutzung sofort Dienstkleidung vorhanden Mitarbeiter waschen Dienstkleidung selbst. Belehrungsnachweise über besondere Behandlung der Wäsche liegt vor? Keine vorgeschriebene Berufskleidung, wird aber empfohlen. Schutzkleidung: (Einmalschürzen, Mundschutz, etc.) - bei Möglichkeit der Kontamination mit Körperflüssigkeiten /Ausscheidungen ist Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Kittel/Schürze, Handschuhe, ggf. Schutzbrille, Mund-Nasen-Schutz) - Arbeitgeber verantwortlich für ausreichende Stückzahl, Reinigung, Desinfektion, Instandsetzung - Wechsel täglich bzw. bei Verschmutzung sofort - bei besonderen aseptischen Anforderungen ist separate Schutzkleidung zu verwenden	☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein Wechselkleidung vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein
--	---

3.3. Umgang mit Lebensmittel als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

MA, die mit LM in Berührung kommen, kennen die §§ 42,43 IfSG und können eine Bescheinigung des GA nach § 43 IfSG vorweisen	☐ Ja ☐ Nein
Werden durch Pflegepersonal LM zubereitet oder gereicht, ist folgendes zu berücksichtigen: - Händewaschung vor und nach Umgang mit LM - bei Verletzungen – Handschuhe - optisch und durch Geruchswahrnehmung von der Genusstauglichkeit der LM überzeugen – Haltbarkeitsdatum prüfen - Anlieferung in gereinigten und geschlossenen Behältern - Warme Speisen müssen bei der Ausgabe eine Temperatur von > 65°C aufweisen, nicht verwertete Speisen kühl lagern - Tee sollte mindestens 2x täglich zubereitet werden (keine langen Standzeiten) - Keine Zugabe von Rohrei zu Speisen, die nach der Zubereitung nicht mehr erhitzt werden - Die zur Herstellung von Speisen verwendeten Utensilien, Geschirr- und Besteckteile müssen sauber sein	☐ Ja ☐ Nein ☐ teilweise

3.4. Abfallbeseitigung als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Anforderungen an das Sammeln und Entsorgen: - reißfeste flüssigkeitsdichte Beutel für Abfälle die mit Blut, Sekreten und Exkrementen behaftet sind – nicht dem dualen System zuführen - bruch- und durchstichsichere, fest verschlossene Behälter für Spritzen, scharfe und zerbrechliche Gegenstände - Altmedikament – Entsorgung über Apotheke, zugriffssicher	☐ Ja ☐ Nein Sind geeignete Behälter, Beutel vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein	Pflegesassessmet:
---	--	--------------------------

3.5. Erste Hilfe als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Jährliche Belehrung der Mitarbeiter (gemäß BGV A5 bzw. GUV 0.3)	☐ Ja ☐ Nein
Geeignetes Erste – Hilfe – Material, Kasten, (gemäß BGV A5/GUV 0.3), Größen gemäß DIN)	☐ Ja ☐ Nein
Bei ja, DIN-Nummer : letzte Überprüfung:	

4. Spezielle Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

4.1 Belehrung von Personal, das Speisezubereitung vornimmt - liegt Belehrung nach 3 Monate nach Ausstellung der Erstbescheinigung des GA vor - schriftliche Erklärung das keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot vorliegen - aktenkundige Belehrung, 1x jährlich	☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein
4.2. Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen Festlegung des Meldeweges, (wichtige Meldeinhalte, wichtige Sofortmaßnahmen, wichtige Telefonnummern)	☐ Ja ☐ Nein



5. Anforderungen nach der Biostoffverordnung als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

5.1. Gefährdungsbeurteilung, Beurteilung der arbeitsplatzbedingten Gefährdungen – die notwendigen Schutzmaßnahmen ermitteln (Regelung und Nachweise vorhanden?)	☐ Ja ☐ Nein	
5.2. Arbeitsmedizinische Voruntersuchungen, gemäß § 15 BioStoffV (Regelung und Nachweise vorhanden?)	☐ Ja ☐ Nein	
5.3. Impfungen für das Personal (aktueller Impfschutz soll in Abhängigkeit von der Tätigkeit vorliegen für Hepatitis A/B, Influenza, Diphtherie, Tetanus und Polio) (Regelung und Nachweise vorhanden?)	☐ Ja ☐ Nein	

6. Sondermaßnahmen beim Auftreten bestimmter Infektionskrankheiten/Parasitenbefall

In jedem Fall ist vor der Einleitung von Maßnahmen das GA einzubeziehen.	☐ Ja ☐ Nein	
6.1. Durchfallerkrankung Klärung der Ätiologie, Übertragungsweg, Infektionsquelle - Angemessene Distanzierungsmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Erreger - Aufklärung der Erkrankten + Kontaktpersonen zu den Hygienemaßnahmen - Festlegung und Überprüfung hygienischer Maßnahmen	☐ Ja ☐ Nein	
6.2. Läusebefall - Unverzügliche Behandlung - Nachkontrolle und Wiederholungsbehandlung nach 9 - 10 Tagen, bei Kleiderlaus 8 - 9 Tagen - sofortiger Wäschewechsel, Handtücher, Leib- und Bettwäsche bei mind. 60°C (>20 min) waschen, Reinigung aller Kontaktflächen usw. - thermische Behandlung nicht möglich: Aufbewahrung in einem gut verschließbarem Plastiksack für mind. 3 Wochen (Kopflaus) und 6 Wochen (Kleiderlaus) bei Zimmertemperatur oder Tiefrieren unter – 10°C über 24 h Bei Kleiderlausbefall erfolgen weitere Maßnahmen nach Vorgaben des Gesundheitsamtes.	☐ Ja ☐ Nein	
6.3. Scabies (Krätze) - sofortiges Einschalten eines Dermatologen zur Diagnostik und Therapie - Begrenzung auf wenige Pflegekräfte - Tragen von Schutzkleidung - Wäschewechsel täglich - Wäschebehandlung, so heiß wie möglich waschen bzw. 14 Tage in einen Plastiksack aufbewahren - Entwesung von Matratzen, Polster, Fußbodenbeläge durch wiederholtes starkes Absaugen Eine chemische Entwesung der Räume ist nicht erforderlich. Ständige Überwachung aller Behandelten und Kontaktpersonen über 6 Wochen. (verantwortlich: Gesundheitsamt)	☐ Ja ☐ Nein	

7. Hygiene bei speziellen Behandlungsmethoden Die folgenden Maßnahmen müssen den gleichen Hygienestandard entsprechen, wie im Krankenhaus. Anlage: Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (RKI)

Pflege Tätigkeit	Bewertung	Regelung in Hygieneplan bzw. Pflegestandard?
Injektion/Punktion	☐ Ja ☐ Nein	
Insulininjektion mit PEN	☐ Ja ☐ Nein	
Infusionstherapie	☐ Ja ☐ Nein	
Wundverbände/Verbandswechsel	☐ Ja ☐ Nein	
Absaugung/Pneumonieprophylaxe	☐ Ja ☐ Nein	
Inhalation/Sauerstoffinsufflation	☐ Ja ☐ Nein	
Katheterisierung der Harnblase	☐ Ja ☐ Nein	
Physiotherapie	☐ Ja ☐ Nein	
Umgang mit Medikamenten	☐ Ja ☐ Nein	
Sondenernährung	☐ Ja ☐ Nein	
Stomapflege (Uro- und Enterostoma)	☐ Ja ☐ Nein	
Hautpflege/ Dekubitusprophylaxe	☐ Ja ☐ Nein	
Mund- und Zahnhygiene	☐ Ja ☐ Nein	



Haar-, Nagelpflege und Rasur	☐ Ja ☐ Nein	
Reinigung des äußeren Gehörganges	☐ Ja ☐ Nein	
Nasenpflege	☐ Ja ☐ Nein	

9. Hygienische Untersuchungen als Teil des Hygieneplanes bzw. Hygienehandbuches

Folgende Untersuchungen: (-in Zusammenarbeit mit dem GA)	☐ Ja ☐ Nein	
- hyg. Überprüfung von Desinfektionsgeräten, Geräte zu Wiederaufbereitung von Materialien		
- hyg. Überprüfung der Sterilisation mittels Bioindikatoren		

Hinweise des Robert-Koch-Institutes

Anzuwendende und zu berücksichtigende Hinweise	vorhanden	
• Empfehlung „Anforderung an Schutzkleidung“	☐ Ja ☐ Nein	
• Empfehlung „Händehygiene“	☐ Ja ☐ Nein	
• Empfehlung „MRSA“	☐ Ja ☐ Nein	
• Empfehlung „nosokomiale Pneumonie“	☐ Ja ☐ Nein	
• Empfehlung zu „katheterassoziierte Harnwegsinfektion“	☐ Ja ☐ Nein	
• Empfehlung „Flächendesinfektion“	☐ Ja ☐ Nein	

Anlagen

Maßnahmen beim Auftreten von MRSA	☐ Ja ☐ Nein	
andere Massnahmekataloge (bspw. Influenza, ESBL etc.)	☐ Ja ☐ Nein	bei, ja welche

Bemerkungen:

Prüfer der Dokumente

Prüfer vor Ort